УГАДАЙ СНИМОК · МОДУЛЬ 3 ИЗ 4

Яичники

8 эхограмм. Посмотрите на снимок, прочитайте короткую вводную и выберите один из четырёх вариантов. Ответ и разбор — на следующем слайде.

01

На ответ — 30 секунд. Варианты называет вслух вся группа.

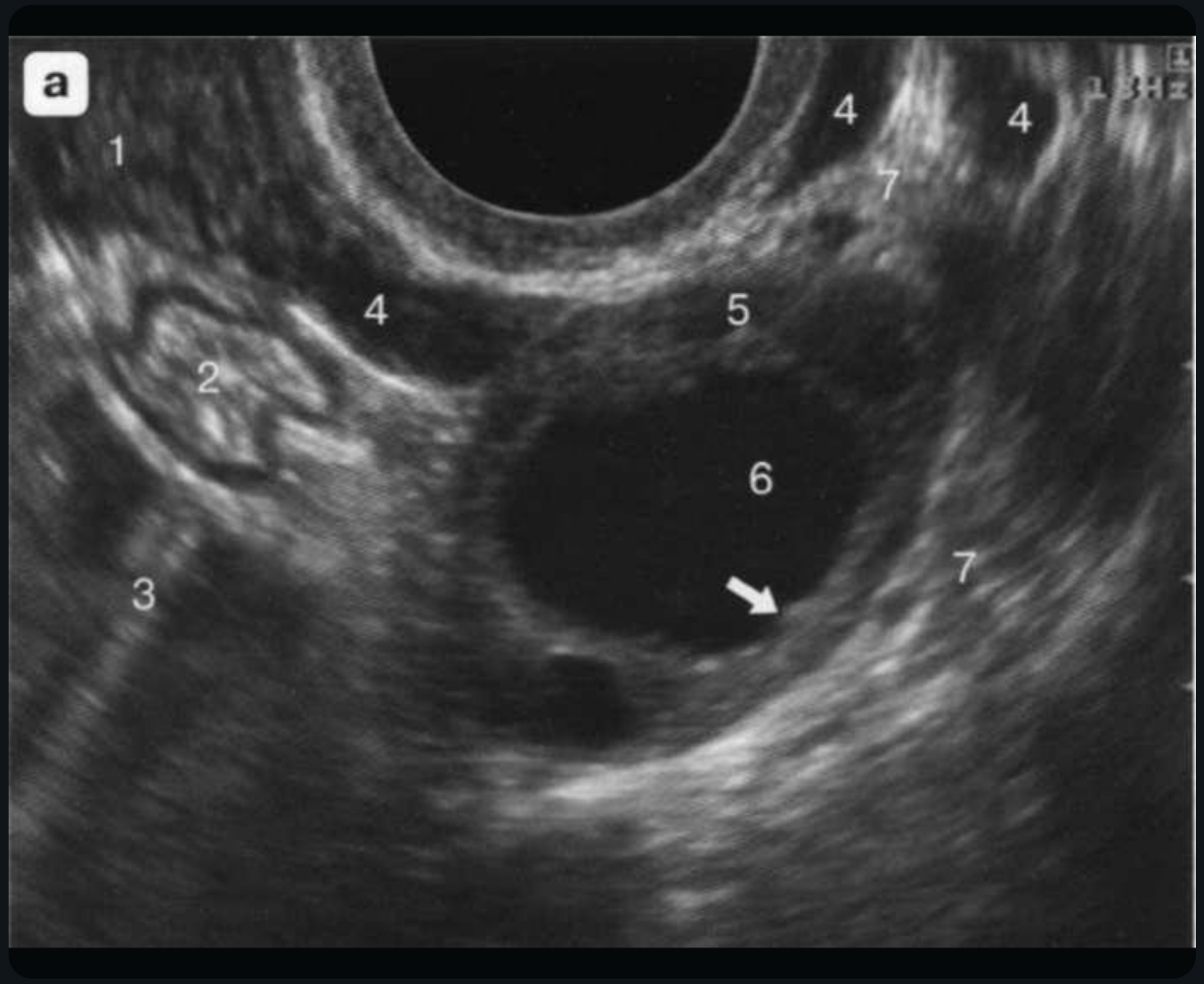
02

Назовите не только диагноз, но и признак, по которому вы его поставили.

03

Балл за верный ответ, ещё балл — за названный признак.

Жумагулов Н.М. · АДЦ «Сономедплюс», г. Ош · Первичная специализация по УЗ-диагностике

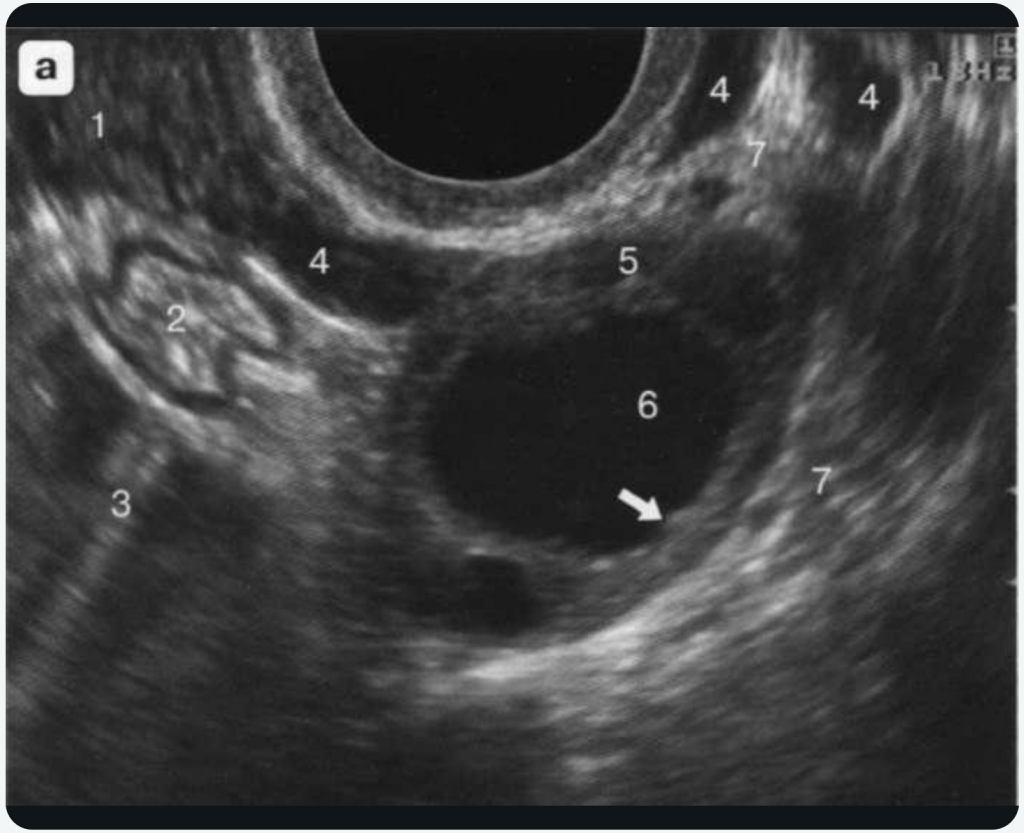


Снимок 1 / 8

Репродуктивный возраст. ТВУЗИ, яичник: анэхогенная тонкостенная структура 19 мм (6).

Ваше заключение?

- **А** Фолликулярная киста
- **Б** Доминантный фолликул
- **В** Эндометриома
- **Г** Желтое тело



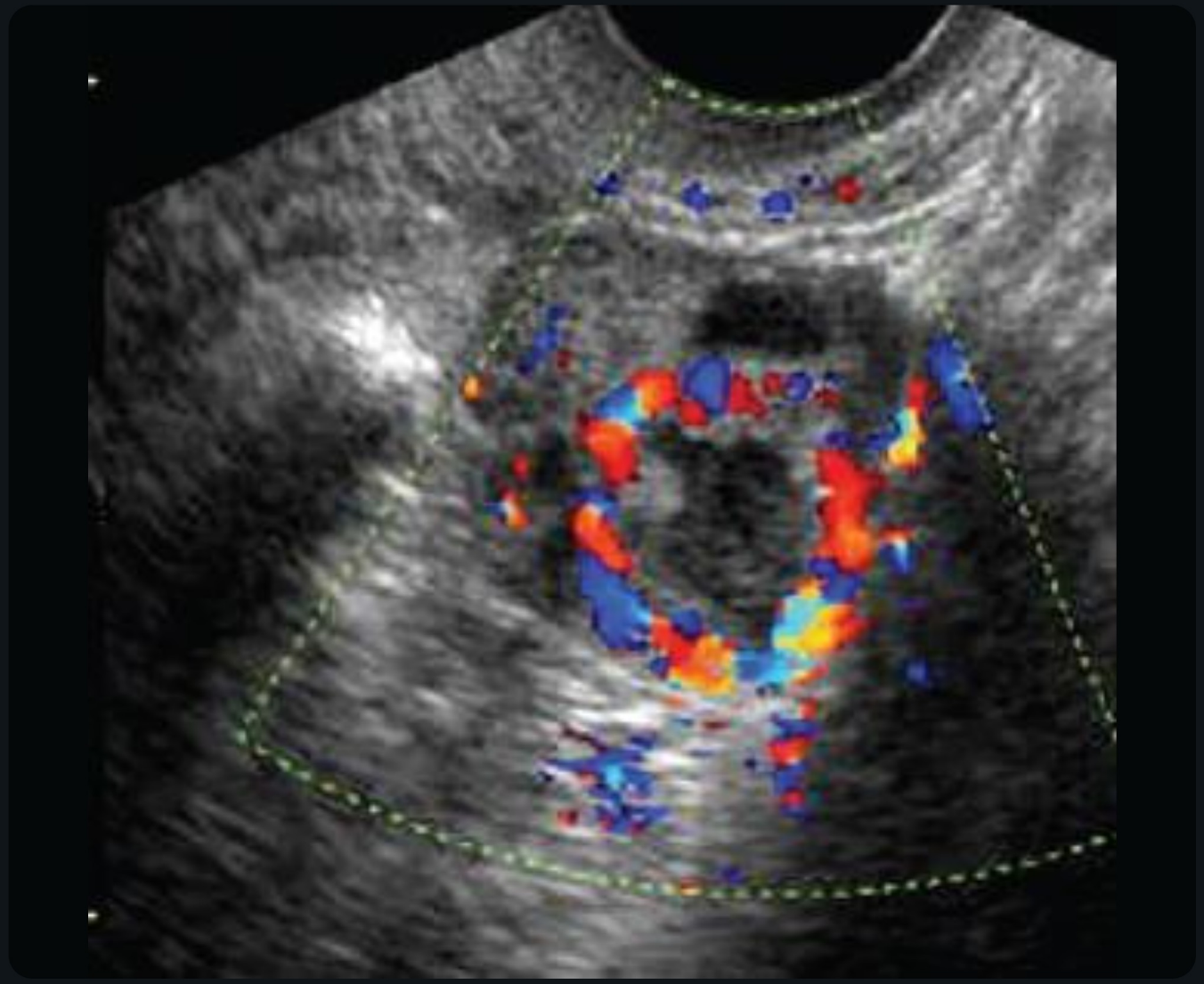
Ответ · Б

Доминантный фолликул

- Округлая анэхогенная структура с тонкой стенкой и дистальным усилением.
- Преовуляторный фолликул обычно 18–25 мм; на стенке бывает виден яйценосный бугорок (стрелка).
- Рядом — мелкие фолликулы, строма яичника обычная.

Вывод: простая анэхогенная структура до 3 см в пременопаузе — физиологический фолликул, а не киста. Наблюдение не нужно.

Источник: Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология, т. 1, рис. 2.27а

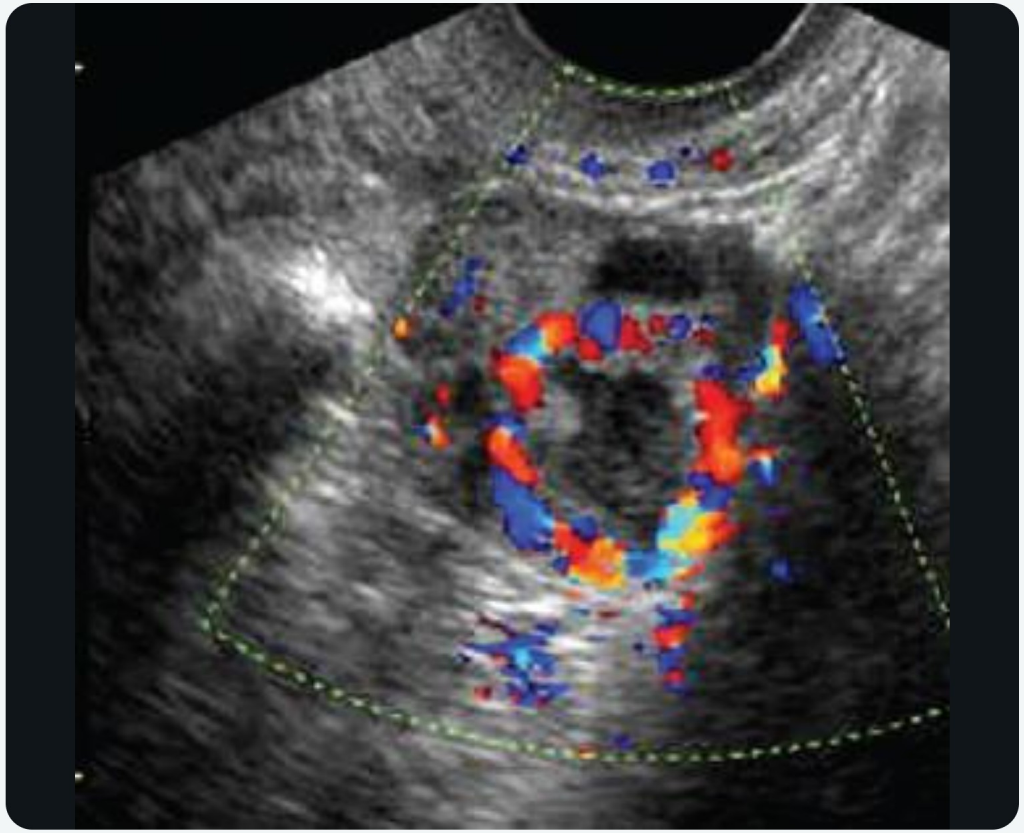


Снимок 2 / 8

Беременность раннего срока. ТВУЗИ с ЦДК, структура в проекции яичника.

Ваше заключение?

- **А** Трубная беременность
- **Б** Желтое тело
- **В** Злокачественная опухоль
- **Г** Перекрут яичника



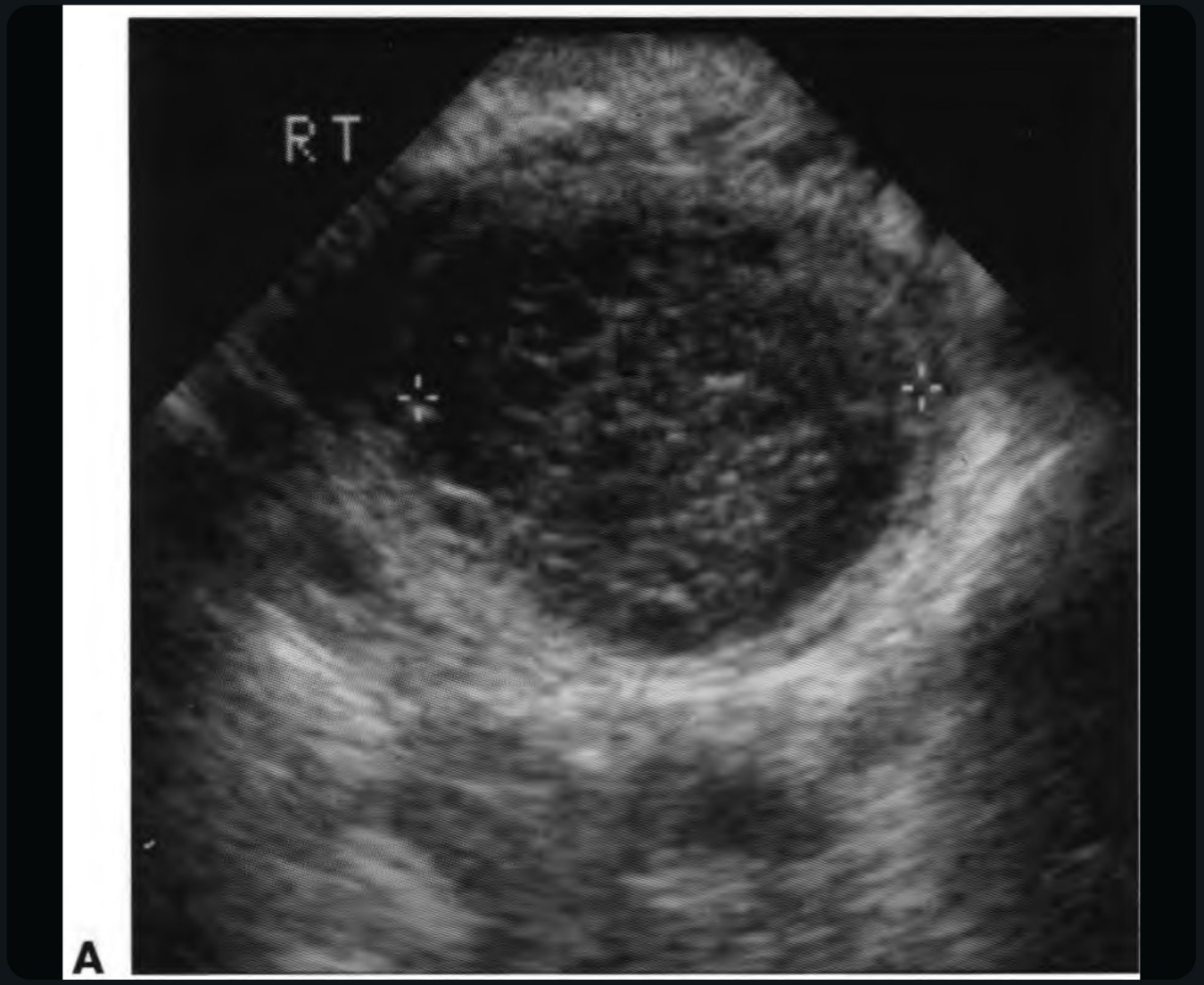
Ответ · Б

Желтое тело беременности

- Кровоток по периферии — «огненное кольцо», внутри аваскулярно.
- Лежит внутри яичника, в пределах его контура.
- При ранней беременности видно почти всегда (98%), в среднем около 2 см.

Вывод: «огненное кольцо» бывает и у трубной беременности. Решает положение: желтое тело смещается вместе с яичником при надавливании датчиком, трубное кольцо — отдельно от него.

Источник: Dr. Yuliya. Ургентная сонография при ранней беременности (2017), с. 74

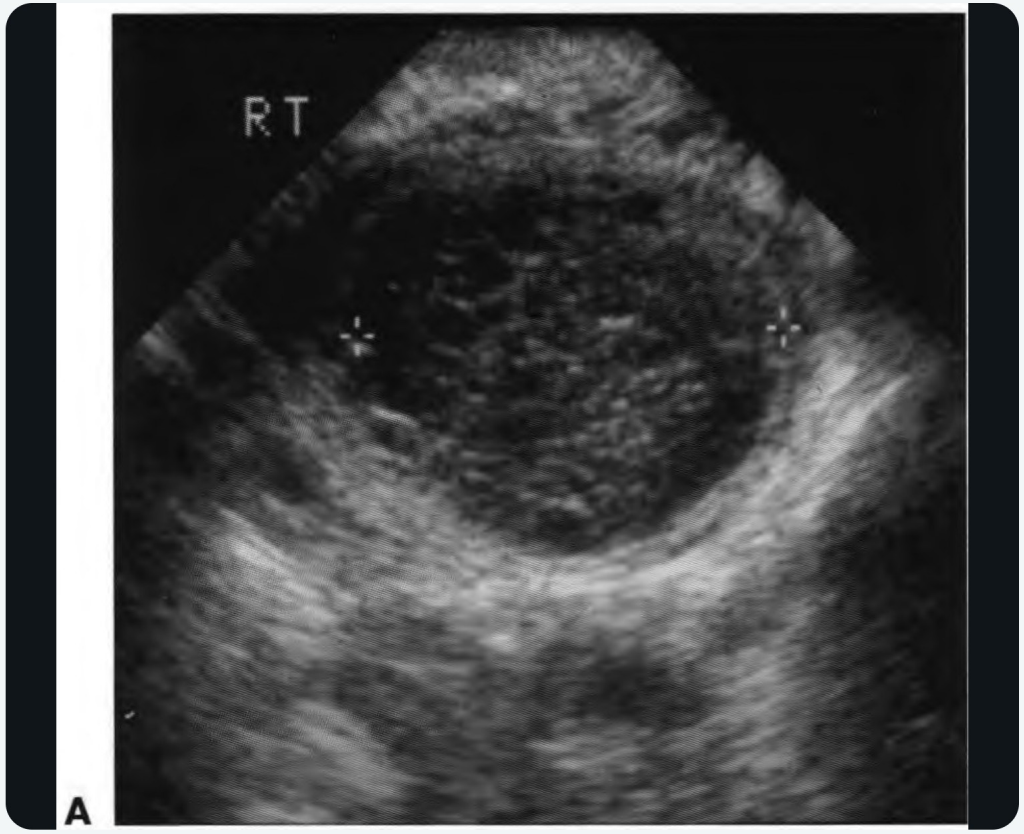


Снимок 3 / 8

ТВУЗИ, правый яичник. При ЦДК кровотока внутри образования нет.

Ваше заключение?

- **А** Эндометриома
- **Б** Геморрагическая киста
- **В** Зрелая тератома
- **Г** Многокамерная цистаденома



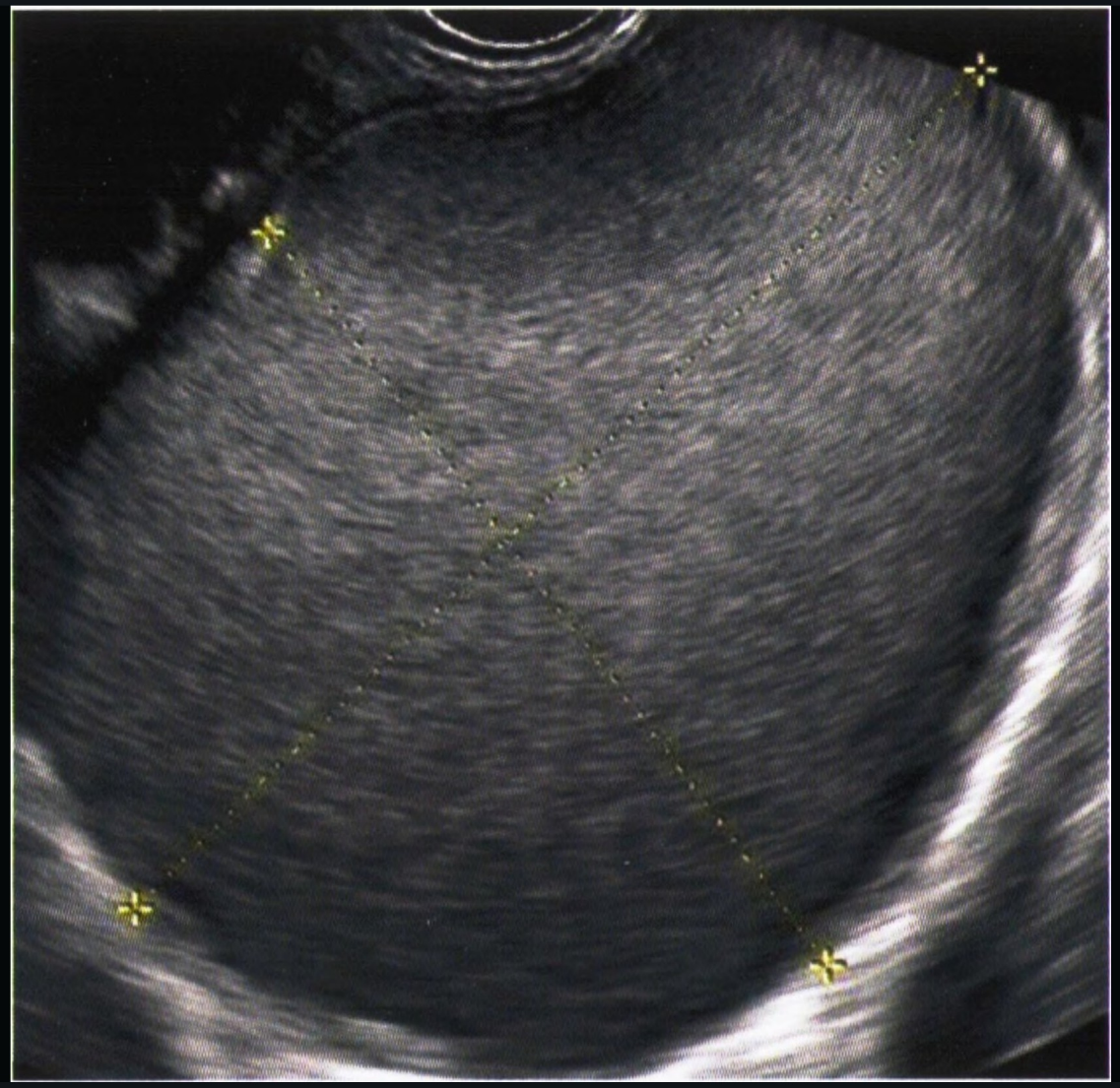
Ответ · Б

Геморрагическая киста

- Мелкосетчатая («кружевная») структура — нити фибрина.
- Ретрагирующий сгусток бывает с вогнутым краем; он не васкуляризирован.
- Стенка тонкая, кровоток только по периферии.

Вывод: перегородки цистаденомы — сплошные линии, а здесь сеточка без кровотока. Контроль через 6–12 недель: геморрагическая киста уменьшается или исчезает.

Источник: Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас по УЗД в акушерстве и гинекологии, рис. 27.2-2 А

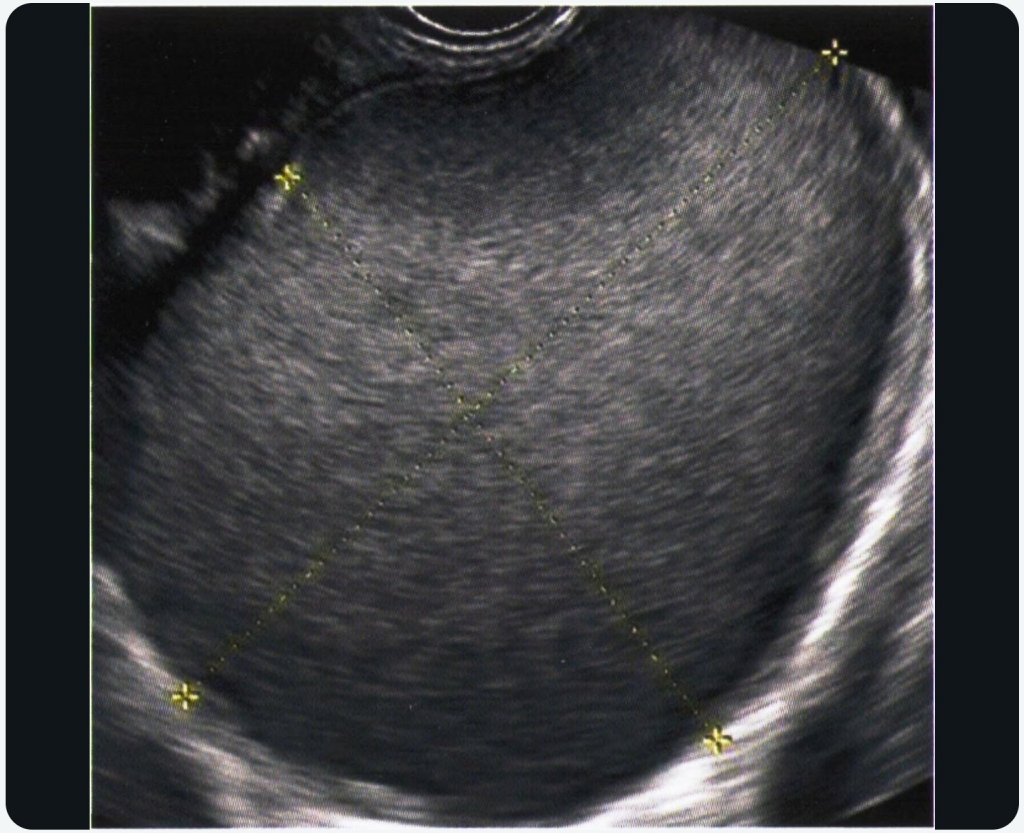


Снимок 4 / 8

ТВУЗИ, яичник. Однокамерное образование с толстой стенкой, солидного компонента нет.

Ваше заключение?

- **А** Простая киста
- **Б** Геморрагическая киста
- **В** Эндометриома
- **Г** Зрелая тератома



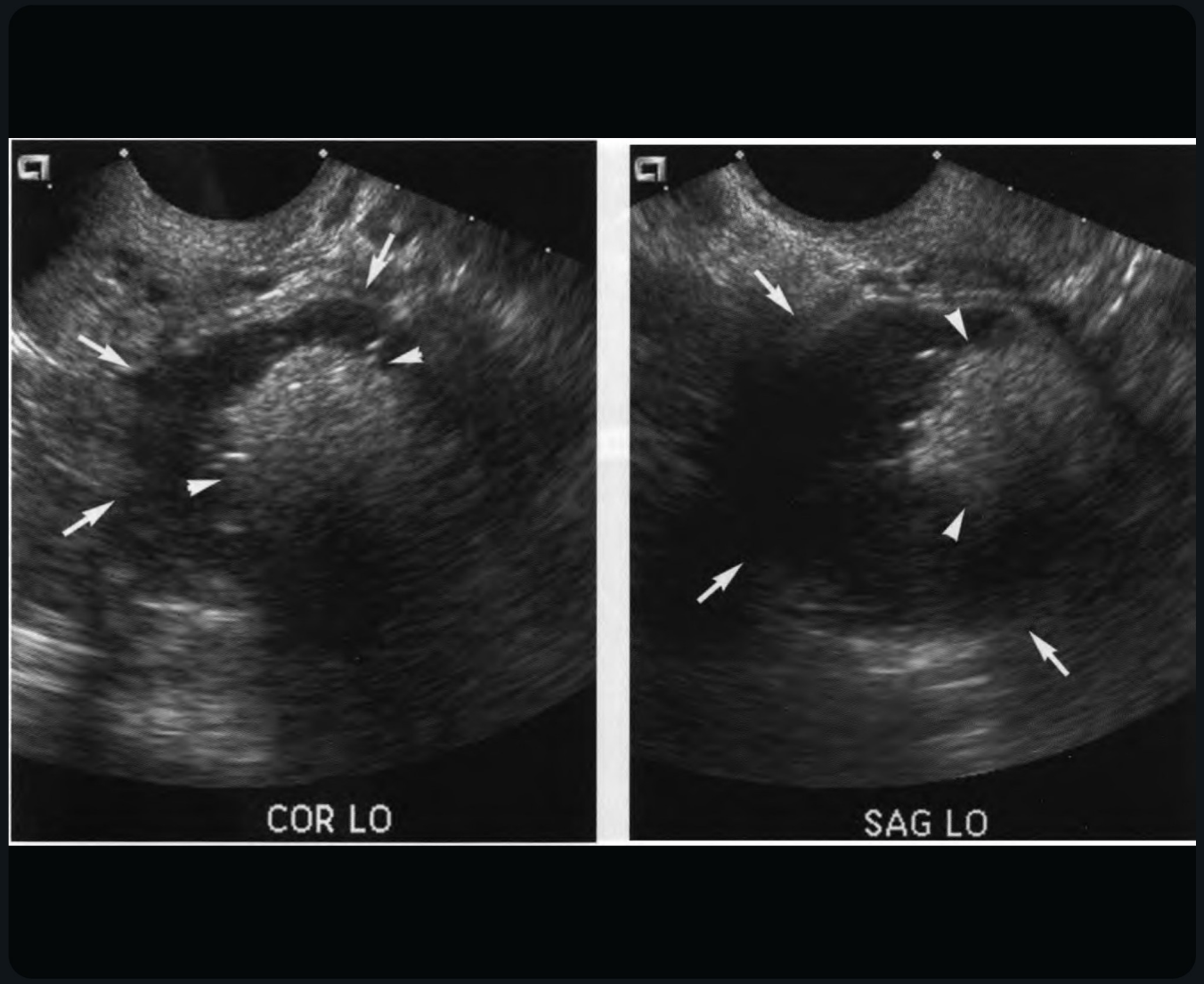
Ответ · B

Типичная эндометриома

- Однокамерная киста с толстой стенкой.
- Однородное мелкодисперсное содержимое — «матовое стекло».
- Нет солидного компонента и внутреннего кровотока.

Вывод: однокамерная киста с «матовым стеклом» в пременопаузе — доброкачественный дескриптор IOTA (вероятная эндометриома). Измерьте три размера и ищите спайки и глубокий эндометриоз.

Источник: Медведев М.В. и соавт. Ультразвуковая диагностика в гинекологии (2018), рис. 4.1



Снимок 5 / 8

ТВУЗИ, левый яичник, два среза. Стрелки — контур образования, наконечники — гиперэхогенный компонент.

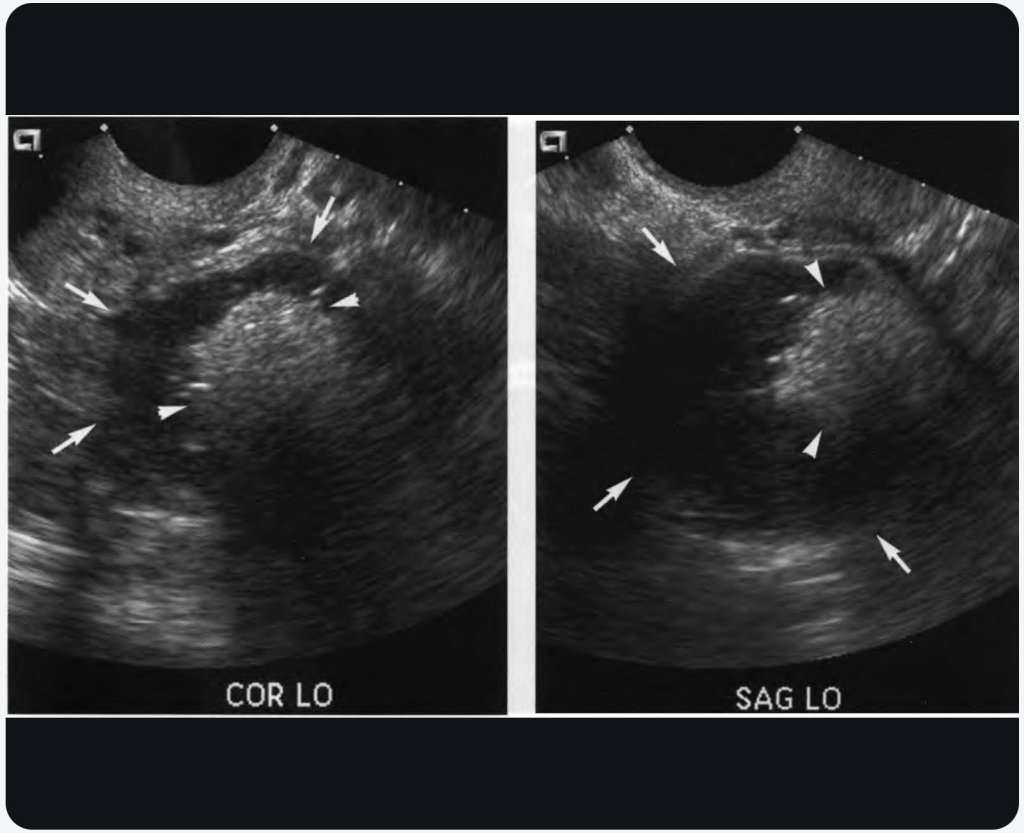
Ваше заключение?

А Геморрагическая киста со сгустком

Б Эндометриома

В Зрелая тератома

Г Пограничная папиллярная опухоль



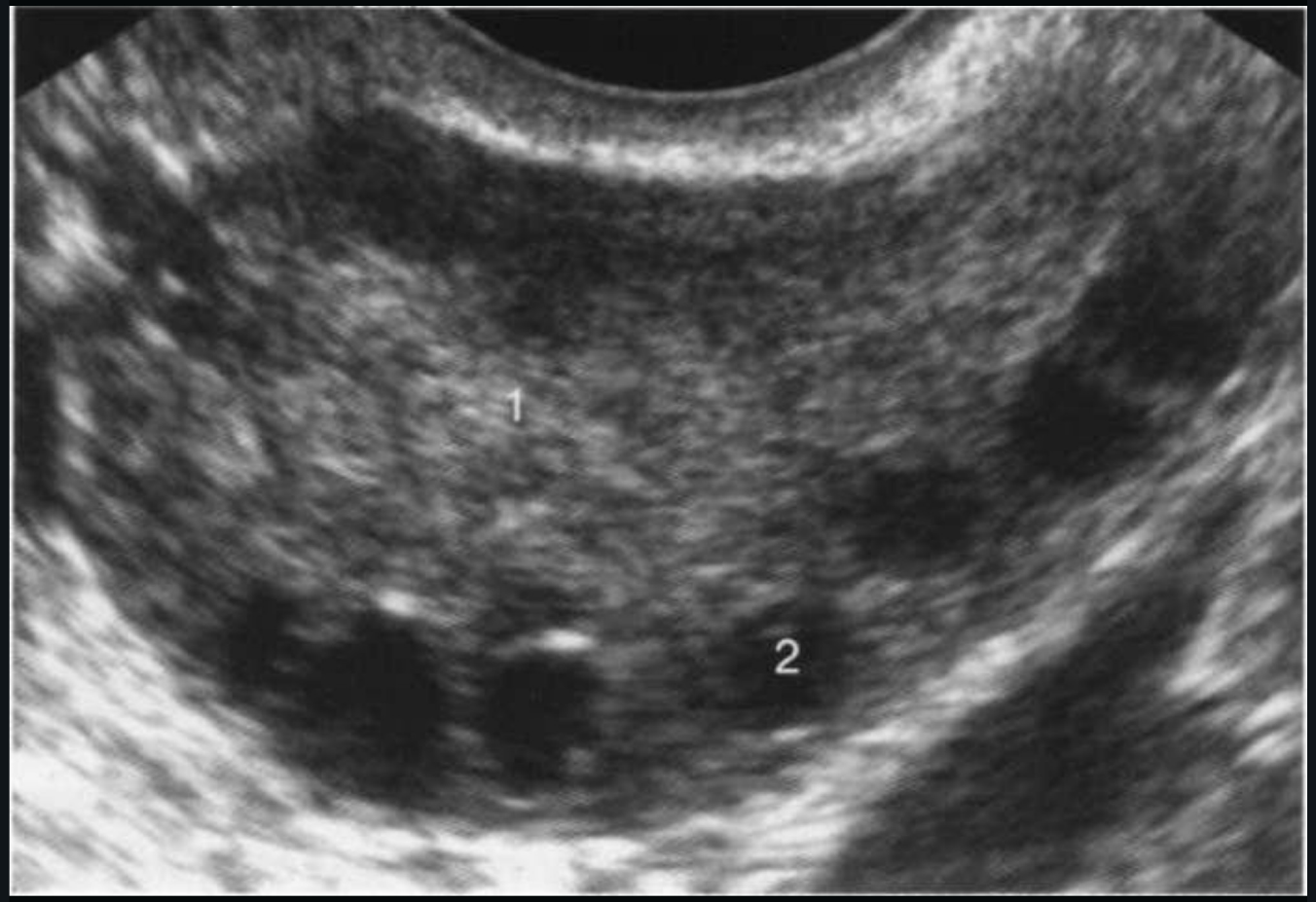
Ответ · B

Зрелая тератома (дермоидная киста)

- Кистозное образование с эхогенным узелком в стенке (бугорок Рокитанского).
- За узелком — акустическая тень.
- Гиперэхогенные участки — жир, волосы, кальцинаты (кость, зубы).

Вывод: тень скрывает задние отделы — «верхушка айсберга». Размер легко недооценить, а саму тератому принять за газ в кишке.

Источник: Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас по УЗД в акушерстве и гинекологии, рис. 27.3-2 B, C



Снимок 6 / 8

ТВУЗИ, яичник. Цифрами 1 и 2 отмечены две структуры.

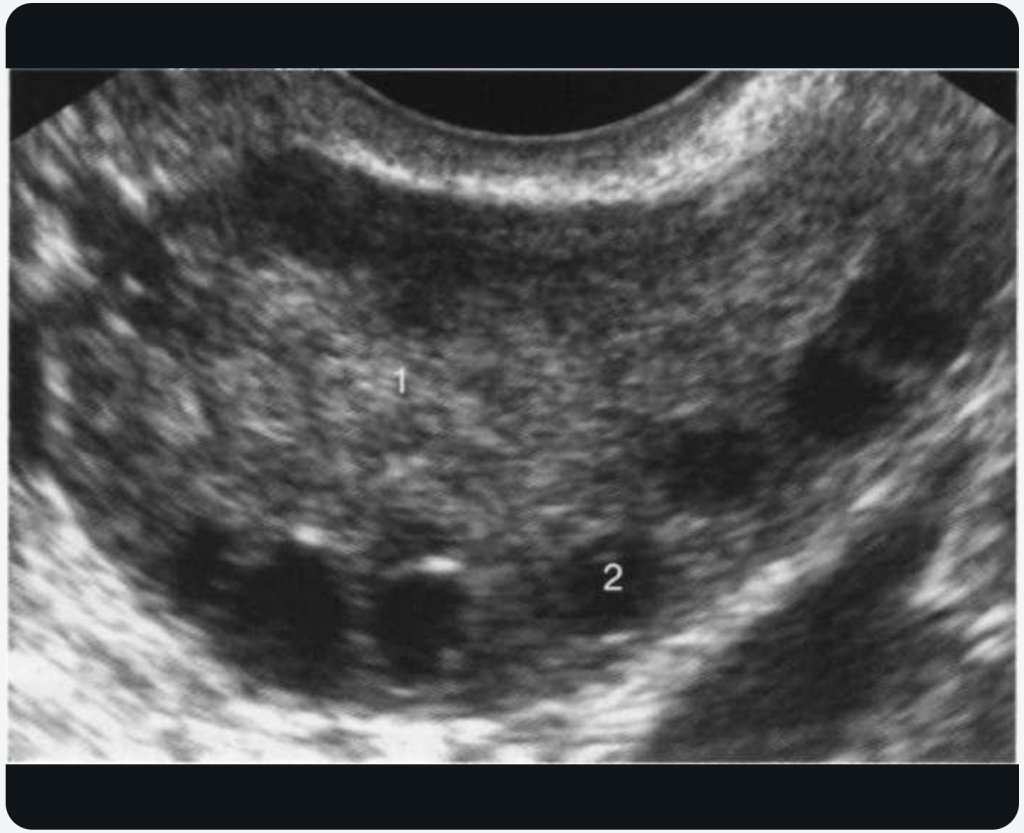
Ваше заключение?

А Поликистозная морфология яичника

Б Многокамерная цистаденома

В Яичник при стимуляции овуляции

Г Перекрут яичника



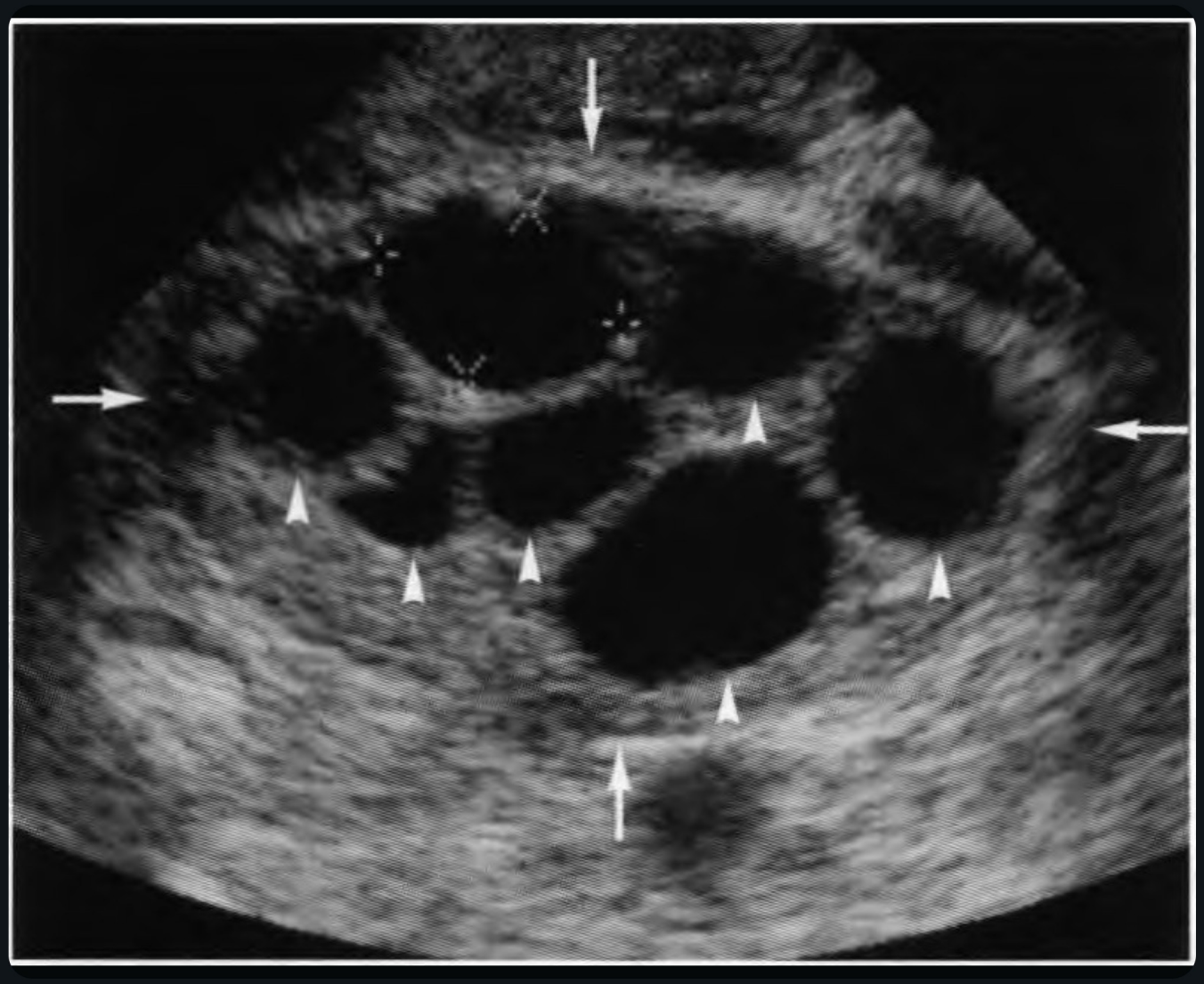
Ответ · А

Поликистозная морфология яичника

- Объём стромы увеличен, она повышенной эхогенности (1).
- Мелкие фолликулы без включений по периферии — признак «чёток» (2).
- Критерии 2023: ≥20 фолликулов 2–9 мм в яичнике и/или объём ≥10 мл (датчик ≥8 МГц).

Вывод: морфология — не диагноз СПКЯ. Диагноз ставит гинеколог-эндокринолог по 2 из 3 критериев; в первые 8 лет после менархе УЗ-критерий не применяют.

Источник: Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология, т. 1, рис. 4.5



Снимок 7 / 8

ТВУЗИ, яичник (стрелки). Наконечники указывают на анэхогенные структуры.

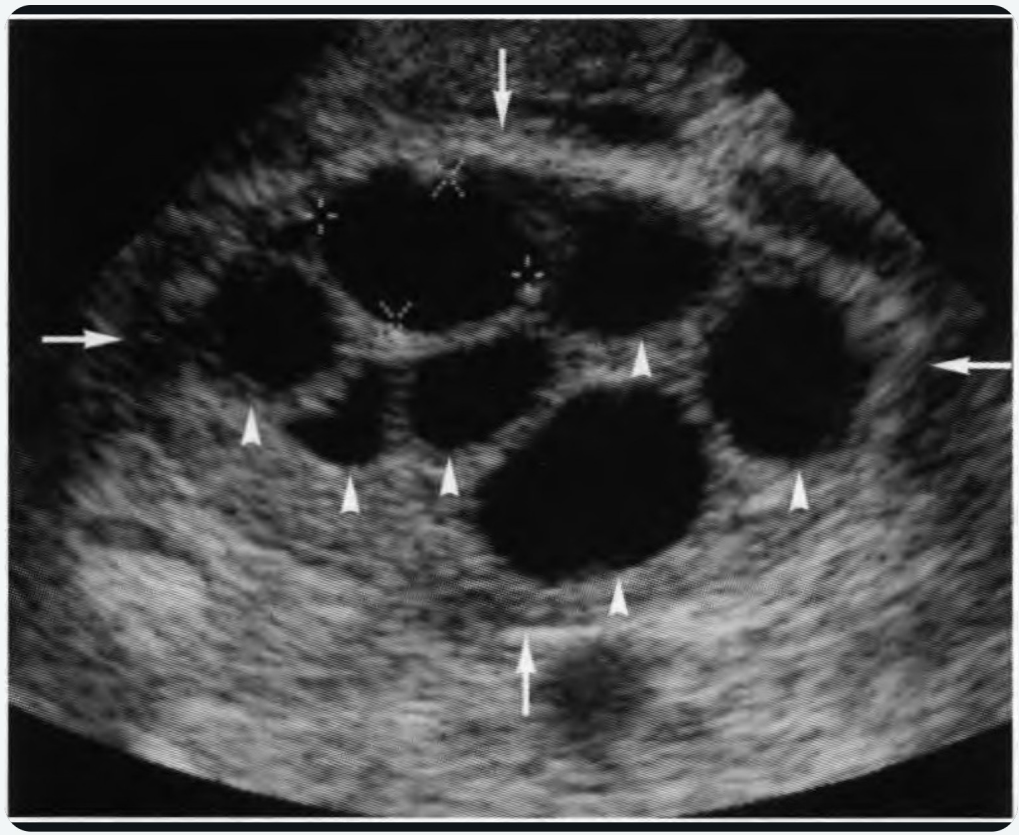
Ваше заключение?

А Поликистозная морфология яичника

Б Яичник при стимуляции овуляции

В Муцинозная цистаденома

Г Тубоовариальный абсцесс



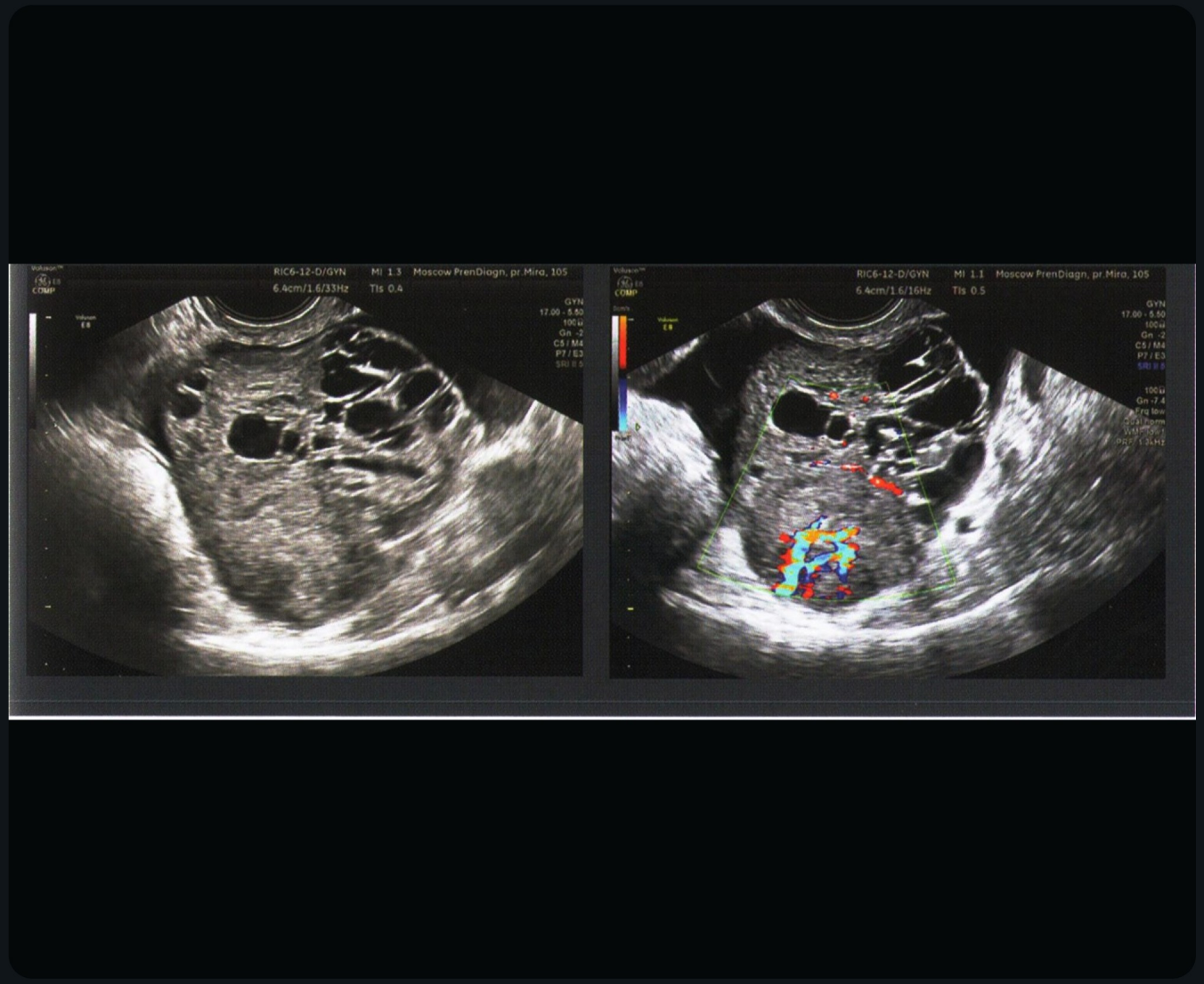
Ответ · Б

Яичник при стимуляции овуляции

- Множественные фолликулы разного, в том числе крупного, размера по всему яичнику.
- «Перегородки» — стенки соседних фолликулов; стромы почти не видно.
- Доля кистозной ткани больше, чем без стимуляции.

Вывод: при стимуляции помните о синдроме гиперстимуляции яичников: опишите размеры яичников и ищите асцит и плевральный выпот.

Источник: Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас по УЗД в акушерстве и гинекологии, рис. 24.1-2



Снимок 8 / 8

Женщина 36 лет. ТВУЗИ: образование яичника и небольшой асцит. Слева В-режим, справа ЦДК.

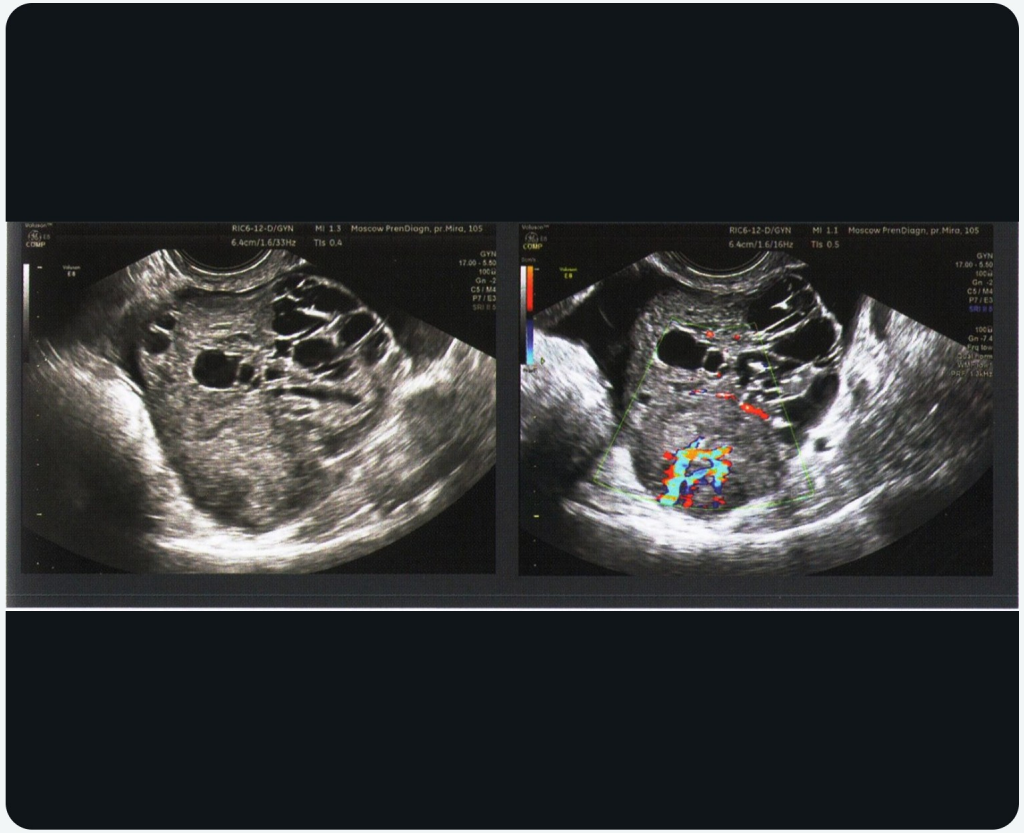
Ваше заключение?

А Муцинозная цистаденома

Б Злокачественная опухоль яичника

В Тубоовариальный абсцесс

Г Нетипичная эндометриома



Ответ · Б

Злокачественная опухоль яичника

- Солидный компонент 89 мм с кровотоком при ЦДК.
- Неровные внутренние контуры стенок, акустической тени нет.
- Асцит — признак М2 простых правил IOTA.

Вывод: модель IOTA LR2 дала 92% вероятности рака; диагноз подтвердился. Такую пациентку направляют к онкогинекологу.

Источник: Медведев М.В. и соавт. Ультразвуковая диагностика в гинекологии (2018), рис. 3.17

Ответы модуля 3

№	Диагноз	Ключевой признак
1	Доминантный фолликул	Тонкостенный, анэхогенный, 19 мм
2	Желтое тело беременности	«Огненное кольцо» внутри яичника
3	Геморрагическая киста	Мелкая сеточка без кровотока
4	Эндометриома	«Матовое стекло», однокамерная
5	Зрелая тератома	Эхогенный узелок с тенью
6	Поликистозная морфология	Строма в центре, «чётки» по периферии
7	Стимулированный яичник	Крупные фолликулы по всему яичнику
8	Рак яичника	Солидный компонент с кровотоком, асцит

Эхограммы: Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология, т. 1; Медведев М.В. и соавт. Ультразвуковая диагностика в гинекологии (2018); Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас (2011); Dr. Yuliya. Ургентная сонография при ранней беременности (2017). Только для учебных занятий группы; для публикации нужно согласие правообладателей.